Клинические рекомендации

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**B34.0** — Аденовирусная инфекция неуточненная **B34.2** — Коронавирусная инфекция неуточненная **B34.9** — Вирусная инфекция неуточненная **B97.0** — Аденовирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках **B97.4** — Респираторно-синцитиальный вирус как причина болезней, классифицированных в других рубриках **J00** — Острый назофарингит (насморк) **J01** — Острый синусит **J02** — Острый фарингит **J03** — Острый тонзиллит [ангина] **J04** — Острый ларингит и трахеит **J05** — Острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит **J06** — Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации **J20** — Острый бронхит **J21** — Острый бронхиолит **J22** — Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 04.08.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"; Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского (НАСИБ)
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/724_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология 3

2.3 Возбудители и ведущие клинические синдромы 3

2.4 Классификация 4

2.5 Критерии степени тяжести 4

2.6 Клиническая картина 4

2.7 Синдромы поражения дыхательных путей 4

2.8 Осложнения 5
2.9 Жалобы и анамнез 5
3. Диагностика 5
3.1 Физикальное обследование 6
3.2 Лабораторные исследования 6
3.3 Инструментальные исследования 6
3.4 Консультации специалистов 7
3.5 Алгоритм ведения на амбулаторном этапе 7
3.6 Дифференциальная диагностика 7
3.7 Дифференциально-диагностические признаки основных ОРВИ 8
4. Лечение 9
4.1 Базисная терапия 9
4.2 Противовирусная терапия 9
4.3 Жаропонижающая терапия 10
4.4 Местная терапия ринита и риносинусита 10
4.5 Местная терапия фарингита и тонзиллита 11
4.6 Противокашлевая и мукоактивная терапия 11
4.7 Антибактериальная терапия 12
4.8 Антибактериальная терапия бактериального риносинусита 12
4.9 Терапия тяжёлого течения 12
4.10 Дополнительная терапия 13
4.11 Медицинская реабилитация 13
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 13
5.1 Показания к госпитализации 13
5.2 Диспансерное наблюдение 14
5.3 Профилактика 14
6. Источник и актуальность 15
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 15

1. Основные положения

- При неосложнённой ОРВИ в первые 10–14 дней антибактериальная терапия не назначается, в том числе при наличии ринита, конъюнктивита, затемнения околоносовых пазух на рентгенограмме, ларингита, крупа или бронхита.
- При затруднении носового дыхания более 3–5 дней и подозрении на бактериальный синусит необходимы рентгенография или компьютерная томография (КТ) околоносовых пазух для своевременного направления пациента к оториноларингологу. Данное осложнение встречается в 0,5–2% случаев, а изменения в пазухах не всегда свидетельствуют о бактериальном воспалении.
- Приём противовирусных препаратов начинают не позднее 48 часов от начала заболевания: в первой линии препараты прямого противовирусного действия, во второй линии иммунотропные препараты.
- При выраженной заложенности носа при рините и риносинусите применяют местные деконгестанты, которые облегчают носовое дыхание и восстанавливают проходимость слуховой трубы.
- Препаратом выбора при бактериальном риносинусите является амоксициллин по 500–1000 мг 3 раза в сутки в течение 7–10 дней.
- Показаниями к срочной госпитализации являются частота дыхания более 24 в минуту, сатурация ниже 95%, очаговые изменения на рентгенограмме грудной клетки.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) представляют собой группу вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём и поражающих преимущественно верхние, реже нижние дыхательные пути.

Грипп А и В и новая коронавирусная инфекция (SARS-CoV-2) рассматриваются в отдельных клинических рекомендациях и в данном документе не освещаются.

2.2 Этиология

Наиболее частыми возбудителями ОРВИ являются респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) А и В, респираторный энтеровирус, риновирус, аденовирус, метапневмовирус человека, вирусы парагриппа 1–4 типов и сезонные коронавирусы. Большинство из них относится к РНК-содержащим вирусам. Их объединяют общие механизмы и пути передачи, стадии развития заболевания и клинические проявления.

2.3 Возбудители и ведущие клинические синдромы

Возбудитель	Основные синдромы
Вирусы парагриппа	Ларингит, ринофарингит, ложный круп
Респираторно-синцитиальный вирус	Бронхит, бронхиолит
Аденовирусы	Фарингит, тонзиллит, бронхит
Риновирусы	Ринит, фарингит
Коронавирусы человека	Ринофарингит, бронхит

Возбудитель	Основные синдромы
Коронавирус ТОРС (тяжёлого острого респираторного синдрома)	Бронхит, бронхиолит, респираторный дистресс-синдром

2.4 Классификация

По типу течения выделяют типичную (манифестную) и атипичную (бессимптомную, стёртую) формы ОРВИ. По тяжести различают лёгкую, среднюю, тяжёлую и очень тяжёлую степень. По характеру течения выделяют неосложнённую и осложнённую формы (со специфическими осложнениями, с осложнениями, обусловленными вторичной микрофлорой, или с обострением хронических заболеваний). По длительности течения различают острую (5–10 дней), подострую (11–30 дней) и затяжную (более 30 дней) формы.

2.5 Критерии степени тяжести

Форма	Признаки
Лёгкая	Температура тела 37–37,5 °С или нормальная, умеренно выраженные катаральные явления, продолжительность заболевания 4–6 дней
Среднетяжёлая	Температура тела 38–39 °С, выраженные катаральные явления; при отсутствии осложнений выздоровление наступает через 6–10 дней
Тяжёлая	Температура тела 39–41 °С; на фоне слабо или резко выраженных катаральных симптомов развиваются угрожающие жизни осложнения

2.6 Клиническая картина

Инкубационный период составляет от 1 до 14 суток, у наиболее распространённых вирусов 1–5 дней. Заболевание, как правило, начинается постепенно с умеренно выраженной интоксикации: повышение температуры тела до субфебрильных или фебрильных значений, слабость, головная боль, боли в мышцах и суставах. Одновременно развивается катаральный синдром: першение в горле, кашель, насморк, в ряде случаев конъюнктивит. Возможно увеличение лимфатических узлов, реже печени (при аденовирусной инфекции).

2.7 Синдромы поражения дыхательных путей

Синдром	Признаки
Острый ринит	Воспаление слизистой оболочки полости носа: чихание, выделения из носа (ринорея), нарушение носового дыхания. Стекание слизи по задней стенке глотки вызывает кашель.
Фарингит	Воспаление слизистой оболочки и лимфоидной ткани глотки: внезапно возникающие першение и сухость в горле, боль при глотании.
Тонзиллит	Изменения нёбных миндалин как вирусной природы, так и при обострении бактериальной (стрептококковой) инфекции. Характерны интоксикация, гиперемия и отёк миндалин, нёбных дужек, язычка и задней стенки глотки, рыхлые налёты в лакунах.
Ларингит	Воспаление гортани с вовлечением голосовых складок и подскладкового пространства. Первыми симптомами являются сухой «лающий» кашель и осиплость голоса.

Синдром	Признаки
Трахеит	Воспаление слизистой оболочки трахеи: саднение и боль за грудиной, сухой надсадный кашель.
Бронхит	Надсадный кашель с небольшим количеством слизистой мокроты, удлинённый выдох, рассеянные сухие хрипы, в тяжёлых случаях одышка. Кашель сохраняется 2 недели и более (до месяца). На второй неделе мокрота может приобретать желтовато-зеленоватый оттенок вследствие примеси фибрина и присоединения бактериальной флоры.

2.8 Осложнения

Осложнения подразделяются на специфические и обусловленные вторичной микрофлорой. К специфическим осложнениям относятся менингизм, острая дыхательная недостаточность, энцефалопатия, инфекционно-токсический шок, респираторный дистресс-синдром взрослых, острая сердечно-сосудистая недостаточность, миокардит, тромбоэмболия.

Вторичная бактериальная микрофлора является причиной острого синусита, острого отита, острого бронхита, обострения хронических бронхолёгочных заболеваний и пневмонии.

2.9 Жалобы и анамнез

У всех пациентов необходимо уточнить наличие недомогания, повышения температуры тела, утомляемости и слабости, снижения аппетита, головной боли, боли в горле, затруднения носового дыхания, насморка, осиплости, сухого или влажного кашля, увеличения лимфатических узлов, боли в животе, одышки, затруднённого вдоха, рвоты, судорог и потери сознания.

Уточняются длительность заболевания, а также наличие причин, препятствующих незамедлительному началу лечения или требующих его коррекции в связи с сопутствующими заболеваниями.

К таким причинам относятся непереносимость лекарственных препаратов, неадекватное психоэмоциональное состояние, угрожающее жизни острое состояние или обострение хронического заболевания, требующее участия профильного специалиста, а также отказ от лечения.

Необходимо уточнить эпидемиологический анамнез: контакт с больным ОРВИ в пределах инкубационного периода, сезонный подъём заболеваемости, вспышки в организованных коллективах, наличие вакцинации против гриппа.

Выявляются факторы риска тяжёлого и осложнённого течения: хронические заболевания лёгких и сердца, нарушения обмена веществ, хроническая болезнь почек, заболевания печени, неврологические состояния, гемоглобинопатии, иммунодефициты (ВИЧ-инфекция, приём иммуносупрессоров), злокачественные новообразования, возраст старше 65 лет, беременность.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании жалоб, анамнеза, данных физикального обследования, лабораторных и инструментальных исследований. Целью диагностики является определение нозологической и клинической формы, степени тяжести, наличия осложнений и показаний к лечению.

3.1 Физикальное обследование

Осмотр начинается с оценки кожных покровов и видимых слизистых оболочек: цвет (гиперемия, бледность, цианоз), влажность, отёчность, инъекция сосудов склер, конъюнктивит. Оцениваются носовое дыхание и признаки ринита, проводится осмотр ротоглотки: гиперемия нёбных дужек и задней стенки глотки, состояние миндалин, рыхлость и зернистость задней стенки глотки, слизистый налёт, увеличение лимфоидных фолликулов.

Катаральные симптомы необходимо выявлять уже на первом этапе обследования, однако они встречаются и при некоторых бактериальных инфекциях, в частности при стрептококковом или менингококковом назофарингите.

Всем пациентам необходимы осмотр и пальпация лимфатических узлов головы и шеи с оценкой их размеров и болезненности.

Обследование всех пациентов включает пальпацию, перкуссию и аускультацию лёгких с оценкой частоты дыхания, характера дыхательных шумов, наличия хрипов и крепитации, которая появляется при пневмонии.

Для оценки степени тяжести, выявления тахикардии, шумов, осложнений и сопутствующих заболеваний необходимы измерение частоты пульса и артериального давления, аускультация сердца.

3.2 Лабораторные исследования

Всем пациентам для оценки степени тяжести, своевременного выявления осложнений и исключения бактериальных осложнений показан общий анализ крови с лейкоцитарной формулой.

Для вирусной инфекции характерны лейкопения или нормальное количество лейкоцитов, лимфоцитоз и моноцитоз.

Всем пациентам выполняют общий анализ мочи для выявления нарушения функции почек, декомпенсации сопутствующих заболеваний, исключения инфекции мочевыводящих путей и нефропатии. При неосложнённой ОРВИ изменения отсутствуют; при выраженной лихорадке возможны преходящее повышение относительной плотности мочи, незначительные лейкоцитурия, протеинурия и цилиндрурия.

При среднетяжёлом и тяжёлом течении необходимы биохимический анализ крови (активность аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), амилазы, уровень мочевины) и исследование уровня электролитов.

Для своевременного назначения противовирусной терапии возбудитель определяется экспресс-методами.

Применяется иммунохроматографический тест для выявления антигенов вирусов гриппа A и B, РСВ, аденовируса и SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки у пациентов, обратившихся не позднее 2 суток от начала симптомов.

Для идентификации возбудителя мазки из носоглотки и ротоглотки исследуются методами амплификации нуклеиновых кислот (полимеразная цепная реакция (ПЦР), петлевая изотермическая амплификация (LAMP) и другие) на вирусы ОРВИ, гриппа и SARS-CoV-2.

Данный метод является наиболее эффективным: нуклеиновые кислоты вирусов выявляются в среднем до 7 дней, максимально до 2 недель от начала заболевания при сохранении признаков поражения верхних дыхательных путей. Результат исследования готов через 4–6 часов.

Обследование пациентов с тонзиллитом и пневмонией осуществляется в соответствии с клиническими рекомендациями по данным заболеваниям.

3.3 Инструментальные исследования

Для ранней диагностики дыхательной недостаточности применяют пульсоксиметрию с измерением сатурации крови кислородом (SpO2). Метод является простым и надёжным способом выявления пациентов с гипоксемией, нуждающихся в респираторной поддержке.

При бронхите продолжительностью более 3–5 дней и при физикальных признаках поражения лёгких для исключения или подтверждения пневмонии показаны рентгенография органов грудной клетки или КТ лёгких.

При затруднении носового дыхания более 3–5 дней и подозрении на синусит вследствие присоединения бактериальной флоры показаны рентгенография или КТ околоносовых пазух для своевременного направления пациента к оториноларингологу.

Данное осложнение встречается в 0,5–2% случаев ОРВИ у взрослых. Изменения в околоносовых пазухах не всегда свидетельствуют об их бактериальном поражении.

При среднетяжёлом и тяжёлом течении, особенно у пациентов пожилого возраста, для оценки функции сердца и выявления нарушений ритма на фоне интоксикации проводится электрокардиография (ЭКГ).

3.4 Консультации специалистов

При подозрении на осложнения показаны консультации смежных специалистов: оториноларинголога при синусите и отите, невролога при энцефалопатии, пульмонолога при признаках пневмонии, гематолога при выраженных изменениях в анализе крови и геморрагическом синдроме, кардиолога при миокардите и острой сердечно-сосудистой недостаточности, акушера-гинеколога при беременности.

При быстро нарастающей острой дыхательной недостаточности (частота дыхания более 25 в минуту, SpO2 ниже 92%) или другой органной недостаточности (2 балла и более по шкале SOFA) показана консультация анестезиолога-реаниматолога для перевода в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).

3.5 Алгоритм ведения на амбулаторном этапе

При выявлении катаральных явлений необходимы общий анализ крови и обследование лёгких. При отсутствии изменений в лёгких лечение амбулаторное; при сохранении лихорадки на фоне лечения анализ крови повторяется, и при выявлении изменений пациент направляется к инфекционисту. При изменениях в лёгких необходима рентгенография; при отсутствии признаков пневмонии проводят рентгенографию околоносовых пазух, и при выявлении изменений в них пациент направляется к оториноларингологу.

3.6 Дифференциальная диагностика

ОРВИ дифференцируют с острыми респираторными заболеваниями бактериальной природы, в том числе вирусной пневмонии с бактериальной.

3.7 Дифференциально-диагностические признаки основных ОРВИ

Возбудитель	Начало и течение заболевания	Лихорадка и интоксикация	Поражение носа и глотки	Кашель и другие проявления
Парагрипп	Инкубационный период 2–7 дней, чаще 3–4; начало постепенное, течение подострое	37–38 °C, может сохраняться длительно; интоксикация слабо или умеренно выражена, 1–3 дня	Катаральные явления с первого дня, осиплость голоса; заложенность носа; слабая или умеренная гиперемия слизистой оболочки зева, мягкого нёба и задней стенки глотки	Сухой «лающий» кашель, в ряде случаев до 12–21 дня; ведущими синдромами являются ларингит и ложный круп
РС-инфекция	Инкубационный период 3–6 дней; начало постепенное, течение подострое, в ряде случаев затяжное	Субфебрильная, в ряде случаев нормальная; интоксикация умеренная или слабая, 2–7 дней	Катаральные явления нарастают постепенно; заложенность носа, необильные серозные выделения; слабая гиперемия слизистых оболочек	Сухой приступообразный кашель до 3 недель с болью за грудиной; бронхит, бронхиолит, возможен бронхоспазм
Аденовирусная инфекция	Инкубационный период 4–14 дней; начало постепенное, течение затяжное, волнообразное	Фебрильная или субфебрильная; интоксикация умеренная, 8–10 дней	Резко выраженные катаральные явления; обильные слизисто-серозные выделения, резкое затруднение носового дыхания; умеренная гиперемия и гиперплазия фолликулов задней стенки глотки	Влажный кашель; ринофаринго-конъюнктивит, тонзиллит, конъюнктивит, кератит; возможны полиаденит, гепатоспленомегалия, экзантема, диарея

4. Лечение

Целями лечения являются подавление репликации вируса в ранние сроки, предотвращение прогрессирования заболевания, достижение полного выздоровления и профилактика осложнений.

Хирургическое лечение не проводится.

4.1 Базисная терапия

Всем пациентам независимо от степени тяжести необходима базисная терапия: постельный режим, диета и обильное питьё. В рацион включаются легкоусвояемые продукты, богатые витаминами; употребление алкоголя в любом виде исключается.

Всем пациентам без поражения лёгких рекомендуется дезинтоксикационная терапия. При лёгком и среднетяжёлом течении в амбулаторных условиях рекомендуется приём 2–3 литров жидкости в сутки. При среднетяжёлом течении в условиях стационара проводятся пероральная регидратация и (или) инфузия 800–2000 мл растворов, влияющих на водно-электролитный баланс. При осложнённом и тяжёлом течении дезинтоксикационную терапию проводят внутривенно с коррекцией электролитных нарушений.

При среднетяжёлом и тяжёлом течении и при поражении лёгких для купирования интоксикации применяют меглюмина натрия сукцинат внутривенно капельно со скоростью 1–4,5 мл/мин, в среднем 10 мл/кг в сутки, курсом до 11 дней.

4.2 Противовирусная терапия

Приём противовирусных препаратов начинают не позднее 48 часов от начала заболевания. Препаратами первой линии являются препараты прямого противовирусного действия, второй линии иммунотропные препараты с опосредованным действием: интерфероны, другие иммуностимуляторы и общетонизирующие средства.

Выбор препарата определяется возбудителем. Раннее назначение противовирусной терапии предупреждает тяжёлое течение и развитие осложнений; целесообразность назначения противовирусного препарата определяется врачом индивидуально для каждого пациента.

Препарат	Доза	УУР, УДД
Риамиловир (первая линия)	Внутрь 250 мг 3 раза в день в течение 5 дней; лечение следует начать не позднее 2-го дня болезни	C, 1
Умифеновир (первая линия)	200 мг 4 раза в сутки (каждые 6 часов) в течение 5 суток. Противопоказан в I триместре беременности	C, 2
Энисамия йодид (первая линия)	Внутрь 500 мг 3 раза в сутки в течение 5–7 дней. Противопоказан при беременности и грудном вскармливании, тяжёлых поражениях печени и почек, непереносимости лактозы и фруктозы	C, 2
Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты (вторая линия)	90 мг 1 раз в день в течение 5–7 дней, приём желательно начать в первые 2 суток. Противопоказан при беременности и в период лактации	C, 5
Меглюмина акридонацетат (вторая линия)	По 4 таблетки однократно на 1, 2, 4, 6 и 8-е сутки (всего 20 таблеток). Противопоказан при беременности и в период лактации	B, 1
Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат (вторая линия)	В первый день 200 мг 3 раза, в последующие 7 дней по 200 мг 1 раз в сутки (на курс 2000 мг)	C, 5

Препарат	Доза	УУР, УДД
Азоксимера бромид (вторая линия)	Таблетки: по 1 таблетке под язык 2 раза в день в течение 7 дней. Раствор: парентерально 6 мг в сутки в течение 3 дней, затем через день, всего 10 инъекций, или интраназально либо сублингвально по 6 мг в сутки в 2–3 приёма. Суппозитории: 12 мг 1 раз в сутки, 10 суппозиториев	C, 5
Тилорон (вторая линия)	125 мг в сутки в первые 2 дня, затем по 125 мг через 48 часов, на курс 750 мг (6 таблеток)	C, 5
Антитела к гамма-интерферону, гистамину и CD4 (Эргоферон)	В 1-й день 8 таблеток: по 1 таблетке каждые 30 минут в течение первых 2 часов, затем ещё 3 раза; со 2-го дня по 1 таблетке 3 раза в день до выздоровления	C, 2
Антитела к гамма-интерферону, CD4 и молекулам MHC (Рафамин)	В 1-й день по той же схеме, затем по 1 таблетке 3 раза в день; общая продолжительность 5 дней, с 18 лет	B, 2

Возможно применение интраназальных интерферонов, которые обладают опосредованным действием и используются в комплексной терапии с первых признаков заболевания. В рекомендации отмечено, что они не входят в перечень препаратов международных клинических рекомендаций.

Интерферон альфа-2b — по 3 капли (дозы) в каждый носовой ход 5–6 раз в день (3000 МЕ на приём, 15 000–18 000 МЕ в сутки) в течение 5 дней.

Интерферон гамма человеческий рекомбинантный — по 2 капли в каждый носовой ход после туалета носа 5 раз в день в течение 5–7 дней.

Пациентам с неосложнённой ОРВИ, а также с частыми, тяжёлыми или затяжными респираторными инфекциями в анамнезе в комплексное лечение для стимуляции иммунитета включаются лизаты бактерий. Препарат принимается с первых дней заболевания по 1 капсуле утром натощак за 30 минут до еды до исчезновения симптомов, но не менее 10 дней.

4.3 Жаропонижающая терапия

При температуре тела выше 38 °C и болях в мышцах и суставах назначаются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Препаратами выбора являются парацетамол по 500–1000 мг каждые 4–6 часов при необходимости, не более 4000 мг в сутки, и ибупрофен по 400 мг 3 раза в сутки, не более 1200 мг в сутки. Возможно применение комбинаций ибупрофена с парацетамолом и парацетамола с фенилэфрином и фенирамином.

НПВП применяются только для снижения температуры тела и обезболивания; длительные курсы нецелесообразны, поскольку могут затруднить оценку эффективности лечения.

4.4 Местная терапия ринита и риносинусита

Физиологический раствор натрия хлорида вводится в полость носа 2–3 раза в день; он разжижает секрет, способствует удалению слизи и восстанавливает функцию мерцательного эпителия.

При выраженном затруднении носового дыхания в комплексном лечении ринита и риносинусита применяются местные деконгестанты для уменьшения заложенности носа и восстановления проходимости слуховой трубы.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Ксилометазолин	По 1–2 капли (1 впрыскивание) 3 раза в день
Нафазолин	По 1–3 капли 0,05–0,1% раствора 3–4 раза в сутки

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Ипратропия бромид + ксилометазолин	Фиксированная комбинация, применяется при обильной ринорее; доза в рекомендации не указана
Оксиметазолин	0,05% раствор, по 1–2 капли или 1–2 впрыскивания 2 раза в сутки

При назофарингите и неосложнённом риносинусите с заложенностью носа, ринореей и стеканием слизи по задней стенке глотки с первого дня назначается комбинированный растительный препарат, содержащий корень горечавки, цветки первоцвета, траву щавеля, цветки бузины и траву вербены. Препарат улучшает функцию мукоцилиарного аппарата и отток экссудата, ускоряет выздоровление и способствует профилактике осложнений.

Сухой экстракт — по 160 мг (1 таблетка) 3 раза в день, измельчённое растительное сырьё — по 156 мг (2 таблетки) 3 раза в день, капли — по 50 капель 3 раза в день; курс 7–14 дней.

Беременным при насморке, назофарингите и остром риносинусите препарат может быть назначен после консультации врача в форме таблеток, а при невозможности их приёма в форме капель.

4.5 Местная терапия фарингита и тонзиллита

Для уменьшения воспаления и болевого синдрома и профилактики вторичной инфекции слизистой оболочки ротоглотки назначаются препараты для лечения заболеваний горла и антисептики в виде полосканий, инсуффляций, ингаляций, таблеток и пастилок для рассасывания.

Применяются грамицидин С с цетилпиридинием (в том числе с оксибупрокаином), бензидамин или флурбипрофен с цетилпиридинием, гексэтидин, лизоцим с пиридоксином, хлоргексидин, бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний, биклотимол и препараты йода.

При фарингите и тонзиллите (боль в горле в покое и при глотании, гиперемия слизистой оболочки глотки и миндалин, увеличение миндалин) назначается растительный антисептик, содержащий корень алтея, цветки ромашки, траву тысячелистника, кору дуба, листья грецкого ореха, траву хвоща и траву одуванчика. Препарат уменьшает болевой синдром и воспаление и способствует профилактике осложнений и повторных эпизодов ОРВИ.

Таблетки — по 2 таблетки (96 мг) 5–6 раз в день, капли — по 25 капель 5–6 раз в день до купирования боли в горле, затем ещё в течение недели 3 раза в день. Препарат может назначаться беременным и пациентам с соматическими заболеваниями после консультации врача.

4.6 Противокашлевая и мукоактивная терапия

При сухом непродуктивном надсадном кашле, значительно ухудшающем качество жизни (болевой синдром, нарушение сна), назначаются противокашлевые средства: бутамират, леводропропизин, антитела к брадикинину, морфину и гистамину или декстрометорфан в составе комбинированных препаратов.

Бутамират в форме сиропа — по 15 мл 4 раза в сутки. Леводропропизин — по 60 мг 1–3 раза в сутки с интервалом не менее 6 часов. Антитела к брадикинину, морфину и гистамину — по 1–2 таблетки или 5–10 мл раствора 3 раза в сутки, в первые 3 дня до 4–6 раз.

При остром вирусном бронхите и трахеите с влажным кашлем и бронхообструкцией назначаются муколитические и отхаркивающие средства, но не в комбинации с противокашлевыми. Муколитические препараты, в том числе растительные, применяются только при продуктивном кашле.

Ацетилцистеин — 600 мг в сутки до 5–7 дней; амброксол — 90 мг в сутки, в форме капсул пролонгированного действия 75 мг в сутки, до 14 дней. Растительные комбинации экстрактов тимьяна с плющом или первоцветом применяются в течение 10–14 дней.

Одновременное назначение отхаркивающих и противокашлевых средств не рекомендуется, поскольку подавление кашлевого рефлекса может привести к застою мокроты.

При остром вирусном бронхите с влажным кашлем для облегчения отхождения вязкой мокроты рекомендуются небулайзерные ингаляции гипертонического раствора натрия хлорида (3% или 7%) с гиалуронатом натрия по 5 мл 2 раза в день.

При бронхообструктивном синдроме, обусловленном бронхоспазмом, применяют комбинацию ипратропия бромида с фенотеролом: в форме дозированного аэрозольного ингалятора по 1–2 вдоха до 3–4 раз в сутки или через небулайзер по 1–2 мл до 3–4 раз в сутки.

При продуктивном кашле, особенно с признаками бронхиальной обструкции, взрослым может назначаться амброксол с гвайфенезином и левосальбутамолом по 10 мл 3 раза в день в течение 2 недель.

4.7 Антибактериальная терапия

При неосложнённой ОРВИ в первые 10–14 дней антибактериальная терапия не назначается, в том числе при рините, конъюнктивите, затемнении околоносовых пазух на рентгенограмме, ларингите, крупе, бронхите и бронхообструктивном синдроме.

К антибактериальной терапии прибегают при вероятной сопутствующей бактериальной инфекции, при неэффективности патогенетической, симптоматической и противовирусной терапии, а также при бактериальных осложнениях среднетяжёлой и тяжёлой ОРВИ (бронхите, пневмонии и других).

4.8 Антибактериальная терапия бактериального риносинусита

Препарат	Доза
Амоксициллин	Внутрь 500–1000 мг 3 раза в сутки в течение 7–10 дней
Амоксициллин и клавулановая кислота	Внутрь 500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки в течение 7–10 дней
Азитромицин	Внутрь 500 мг 1 раз в сутки в течение 3 дней
Кларитромицин	500 мг 1 раз в сутки в течение 7–10 дней (кратность приведена по тексту рекомендации)
Левофлоксацин	Внутрь 500 мг до 5–7 дней; применяется при устойчивой микрофлоре, неэффективности других антибиотиков, экзантеме или лекарственной аллергии на другие антибиотики

> В рекомендации имеется расхождение в сроках. Антибактериальная терапия не рекомендуется до 10–14 дней даже при затемнении околоносовых пазух на рентгенограмме, однако рентгенографию пазух при подозрении на бактериальный синусит рекомендуется выполнять уже при заложенности носа более 3–5 дней, а в разделе об организации медицинской помощи сохранение высокой температуры тела более 3 дней названо клиническим признаком вторичной бактериальной инфекции.

Лечение пневмонии в данных рекомендациях не рассматривается и проводится в соответствии с клиническими рекомендациями по внебольничной пневмонии у взрослых.

4.9 Терапия тяжёлого течения

При тяжёлой ОРВИ с инфекционно-токсическим шоком или отёком головного мозга применяют системные глюкокортикоиды; лечение таких пациентов осуществляется в ОРИТ в соответствии с рекомендациями по неотложным состояниям.

При поражении лёгких с дыхательной недостаточностью (SpO2 ниже 92%) необходима оксигенотерапия через носовые канюли, лицевую маску или аппарат высокопоточной оксигенации. Начальная скорость потока составляет 5–7 л/мин, при необходимости она увеличивается до 10 л/мин для поддержания SpO2 выше 90%.

4.10 Дополнительная терапия

Для защиты слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки на фоне приёма лекарственных препаратов, в том числе НПВП, назначается омепразол 20 мг 1 раз в день.

Пробиотики рекомендованы пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, функциональными расстройствами пищеварения, заболеваниями кожи, а также при приёме антибиотиков более 7 дней в настоящее время или в предшествующие 1–2 месяца. Пробиотики применяются в ранние сроки заболевания в сочетании с другими препаратами.

4.11 Медицинская реабилитация

Реабилитация начинается в периоде ранней реконвалесценции.

При вирусной и поствирусной астении применяют общетонизирующие препараты, в частности оксиэтиламмония метилфеноксиацетат: в первый день 600 мг, в последующие 7 дней по 200 мг, всего 2000 мг за 8 дней.

Восстановительное лечение проводится комплексно, с участием специалистов разного профиля, последовательно и преемственно на всех этапах, с учётом резервов пациента и при постоянном контроле эффективности. Физическая и умственная нагрузка увеличивается постепенно.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Перед выбором тактики ведения определяется характер течения заболевания (неосложнённое или осложнённое).

Лечение лёгкой и среднетяжёлой ОРВИ амбулаторное. При неэффективности лечения или невозможности его проведения в домашних условиях решается вопрос о госпитализации.

Госпитализации подлежат пациенты с тяжёлым, среднетяжёлым и осложнённым течением, пациенты из групп риска, а также пациенты по эпидемическим показаниям, в том числе с лёгким течением при проживании в общежитии или в неблагоприятных условиях.

> В рекомендации имеется противоречие в отношении среднетяжёлого течения: одна рекомендация раздела 6 предусматривает амбулаторное лечение таких пациентов, следующая предусматривает их госпитализацию.

Показаниями к срочной госпитализации являются частота дыхания более 24 в минуту, SpO2 ниже 95%, очаговые изменения на рентгенограмме грудной клетки.

Перевод в ОРИТ показан при быстро нарастающей острой дыхательной недостаточности (частота дыхания более 30 в минуту, SpO2 ниже 90%, систолическое артериальное давление ниже 90 мм рт. ст.) и другой органной недостаточности, например острой почечной недостаточности.

> Пороговые значения для перевода в ОРИТ в разных разделах рекомендации различаются: в разделе 2.5 консультация анестезиолога-реаниматолога показана при частоте дыхания более 25 в минуту и SpO2 ниже 92%, в разделе 6 перевод в ОРИТ показан при частоте дыхания более 30 в минуту и SpO2 ниже 90%.

При прогрессировании заболевания схема ведения пациента подлежит срочному пересмотру. Признаками прогрессирования являются симптомы гипоксии и сердечно-лёгочной недостаточности (одышка, цианоз, кровянистая мокрота, боль в грудной клетке, артериальная гипотензия, снижение сатурации), поражения нервной системы (нарушение сознания, сонливость, судороги, выраженная слабость, параличи), вторичной бактериальной инфекции (в том числе сохранение высокой температуры тела и других симптомов более 3 дней) и тяжёлой дегидратации.

Выписка возможна при стойком улучшении состояния, нормальной температуре тела, после регресса респираторно-катарального синдрома и при нормальных показателях общего анализа крови.

К группам риска тяжёлого течения относятся беременные и родильницы, пациенты с хроническими заболеваниями лёгких, сердца и сосудов, сахарным диабетом и ожирением 2–3 степени, хронической болезнью почек, заболеваниями печени, некоторыми неврологическими состояниями, гемоглобинопатиями, иммунодефицитами, злокачественными новообразованиями, а также лица в возрасте 65 лет и старше.

5.2 Диспансерное наблюдение

При развитии осложнений наблюдение осуществляет терапевт, после аденовирусной инфекции инфекционист кабинета инфекционных заболеваний поликлиники.

В течение месяца после выписки вакцинация не проводится, за исключением введения анатоксина столбнячного и вакцины против бешенства по показаниям.

После перенесённого заболевания рекомендуется ограничение инсоляции на срок от 2 недель до месяца в зависимости от тяжести течения.

5.3 Профилактика

Вакцины против ОРВИ отсутствуют.

Среди контактных лиц выявляют заболевших. Больной изолируется на дому, при необходимости в отдельном боксе стационара, до клинического выздоровления, в среднем на 1–2 недели, после чего может приступить к работе. Карантин для контактных лиц не вводится.

При работе с больными ОРВИ необходимо использование маски со сменой каждые 3–4 часа.

Необходимы обеззараживание посуды, воздуха и поверхностей, влажная уборка и проветривание помещений.

После контакта с больным ОРВИ рекомендуется химиопрофилактика. Экстренная профилактика в очаге продолжается 2 дня при прекращении контакта и 5–7 дней при его сохранении. Плановая сезонная профилактика проводится перед эпидемическим подъёмом заболеваемости лицам с высоким риском заражения и неблагоприятного исхода.

Препарат	Доза для профилактики	УУР, УДД
Умифеновир	После контакта — 200 мг в сутки в течение 10–14 дней; сезонная профилактика — 200 мг 2 раза в неделю в течение 3 недель	B, 3
Оксодигидроакридинилацетат натрия	250 мг (1 ампула) или 4–6 мг/кг на введение; при длительном применении — с интервалом 3–7 суток	C, 4
Интерферон альфа-2b	По 3 капли в каждый носовой ход 2 раза в сутки в течение 5–7 дней; при однократном контакте достаточно однократного закапывания	B, 3
Интерферон гамма человеческий рекомбинантный	По 2–3 капли в каждый носовой ход за 30 минут до завтрака в течение 10 дней	B, 3
Меглюмина акридонацетат	Не позднее 3 дней после контакта — 600 мг (4 таблетки) в сутки на 1, 2, 4, 6 и 8-е сутки	C, 5
Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат	200 мг в сутки после еды в течение 14 дней	C, 5

Препарат	Доза для профилактики	УУР, УДД
Азоксимера бромид	По 1 таблетке в день в течение 10 дней, или 6 мг в сутки интраназально или сублингвально, или суппозитории 12 мг 1 раз в сутки, 10 суппозиториев	C, 5
Тилорон	125 мг 1 раз в неделю в течение 6 недель	C, 5
Антитела к гамма-интерферону (Анаферон)	По 1 таблетке в день в течение 1–3 месяцев в период подъёма заболеваемости	B, 2

Лизаты бактерий применяют для профилактики повторных респираторных инфекций и вторичной бактериальной инфекции независимо от сезона лицам, проживающим в неблагоприятных экологических условиях, и пациентам с хроническими заболеваниями дыхательных путей и глотки: хроническим бронхитом, хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ), бронхиальной астмой, хроническим риносинуситом, хроническим тонзиллитом. Препарат принимается тремя курсами по 10 дней с интервалами по 20 дней.

Взрослым перед эпидемическим сезоном и во время него длительно, от 6 месяцев до года, рекомендуется #колекальциферол: при отсутствии ожирения 2000 МЕ в сутки или 10 000 МЕ в неделю, при ожирении 3000–6000 МЕ в сутки (знак # означает применение вне инструкции по медицинскому применению).

Пациенту разъясняется необходимость срочного обращения к врачу при высокой температуре тела, одышке, стойкой головной боли, повторной рвоте, не приносящей облегчения, и резком снижении артериального давления.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 04.08.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее августа 2028 года
Код в рубрикаторе	724_2 · открыть текст КР ↗
Разработчики	Российское научное медицинское общество терапевтов; Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В разделе 6 одна рекомендация предусматривает амбулаторное лечение среднетяжёлой ОРВИ, а следующая предусматривает госпитализацию.
- Пороговые значения для перевода в реанимацию расходятся: в разделе 2.5 частота дыхания более 25 в минуту и SpO2 ниже 92%, в разделе 6 частота дыхания более 30 в минуту и SpO2 ниже 90%.
- Антибактериальная терапия не рекомендуется до 10–14 дней даже при затемнении околоносовых пазух, однако рентгенографию пазух при подозрении на бактериальный синусит рекомендуется выполнять уже при заложенности носа более 3–5 дней, а сохранение температуры более 3 дней в разделе 6 расценивается как признак вторичной бактериальной инфекции.
- В алгоритме (приложение Б) рентгенография околоносовых пазух предусмотрена только при изменениях в лёгких без признаков пневмонии, тогда как в разделе 2.4 она назначается в

зависимости от длительности затруднения носового дыхания.

- Рекомендации предназначены для взрослых, однако в рекомендации против назначения антибиотиков упоминается «взрослая и детская практика».
- Кларитромицин при риносинусите указан в дозе 500 мг 1 раз в сутки; для оксиметазолина в одной фразе смешаны капли и впрыскивания; доза бромгексина записана неразборчиво («по 8 мг 3 (1–2 таблетки) 3–4 раза в сутки»).
- В разделе 2.2 уровень достоверности доказательств обозначен как «уровень доказательности» и «уровень доказательства»; у рекомендации о пульсоксиметрии уровни указаны после комментария.
- Критерии качества предусматривают коагулограмму, определение маркёров воспаления и антибактериальную терапию при «остром бактериальном тонзиллите», хотя в тексте рекомендаций эти положения отсутствуют.
- В таблице приложения А3.4 для парагриппа в строке ведущего синдрома приведена оборванная фраза «выявляют крайне».